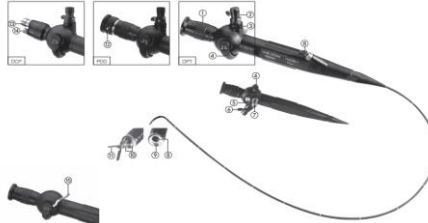
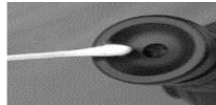
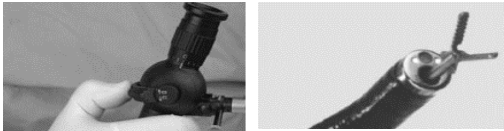


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 15	MES: 03	AÑO: 2023
Nombre del equipo:	Rino-Larigo-FibroscoPIO	Modelo:	11101RP		Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	KARL STORZ				Clasificación del equipo:	Diagnóstico
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		RECOMENDACIONES		
 Los fibroscopios son instrumentos esenciales en la endoscopia, tanto diagnóstica como quirúrgica. Su uso debe restringirse exclusivamente a personal altamente especializado, con la formación y cualificación necesarias. Las indicaciones para su uso incluyen exploración, diagnóstico y terapia, en combinación con accesorios endoscópicos, en diversas áreas de la medicina.				1.No enrolle de forma demasiado apretada el cable. 2.No mueva los botenes de forma brusca. 3.No elimine suciedad con elementos afilados. 4.No ponga objetos encima del fibroscopio.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				MONTAJE		
1.Dirección de visión:0° 2.Angulo de visión:70° 3.Longitud util: 30 cm 4.Diámetro exterior de la punta distal:3,5 mm 5.Desviación hacia arriba / abajo:180 ° / 90 ° 6.Profundidad de campo:5-50 mm		1.Anillo de enfoque (Si aplica) 2.Suplemento p/válvula de succión (si aplica). 3.Pitones de válvula (si aplica). 4.Elemento de mando subir/bajar. 5.Válvula para compensación de presión y para conexión del verificador de estanqueidad. 6.Conexión de succión. 7.Pitones de entrada de luz. 8.Canal para instrumentos. 9.Objetivo. 10.Salida de luz. 11.Instrumento en el canal para instrumentos. 12. Conmutador de filtro PDD 13.Conductor de imagen. 14.Conductor de luz. 15.Mecanismo de cierre (fija la punta).		1.Montaje de la válvula de succión:Coloque el suplemento para válvula de succión sobre los pitones de la válvula y gírelo hasta que los botones laterales encajen en los recortes del manguito. Luego, presione ligeramente para encastrar el suplemento en los pitones."  2.Montaje del soporte del tubo: El soporte del tubo se desliza en la parte distal,fijándolo mediante giro de ambas piezas en dirección opuesta.  3.Montaje de la válvula de labios: Coloque la válvula de labios desechable sobre el canal para instrumentos y tire ligeramente girando en el sentido de reloj. 		
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO						
1.Conecte las líneas de alimentación: Si es necesario, retire el adaptador y conecte el cable de luz o fuente de luz a los pitones de entrada de luz. 2.Mando de la punta distal: El elemento de mando subir/bajar se debe de mover de forma pareja y lenta. 3.Botón de succión: Inicia solo si la bomba de succión esta conectada y en marcha. 4.Insuflación: En anestesia conecte el tubo flexible para de O2 al canal para instrumentos. 5.Enfoque: Nitidez de la imagen. 6.Canal para instrumentos: Se pueden ingresar instrumentos flexibles. 7.Ejecución PDD: ALA para tumores con ácido aminolavulímico, W para luz blanca, AF modo autofluorescente.						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 15	MES: 03	AÑO: 2023

Nombre del equipo:	Rino-Larngo-FibroscoPIO	Modelo:	11101RP	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	KARL STORZ			Clasificación del equipo:	Diagnóstico

LIMPIEZA	ESTERILIZACIÓN	PREPACIÓN DEL FIBROSCOPIO
1.Deslice un paño suave humedecido con agua o desinfectante y páselo por el cuerpo del fibroscopio para retirar los restos de sangre o secreciones. 2.Desconecte todos los accesorios y conectores del fibroscopio 3.Realice pruebas de estanquidad 4.Introduzca el fibroscopio en un tanque amplio con desinfectante. 5.Inyecte o succione desinfectante por el canal de trabajo. 6.Introduzca el cepillo de forma circular por el canal de trabajo y cuando salga por el extremo distal, limpie el cepillo con otro cepillo para eliminar los residuos. Saque el cepillo y repita el paso por lo menos tres veces. 7.Pase nuevamente un paño suave humedecido con desinfectante por lo menos tres veces 8.Desinfecte todos los accesorios y conectores por separado. 9.Enjuague el fibroscopio con agua destilada para eliminar restos del desinfectante. 10.Seque el fibroscopio con un paño suave seco e inyecte aire comprimido por el canal de trabajo (máximo 0,5 bar).	Bajo ninguna circunstancia el equipo debe esterilizarse a vapor (alta temperatura – Autoclave). Los métodos avalados por el fabricante son: 1.ETO 2.STERRAD 3.STERIS	1.Antes de usar el fibroscopio con un paciente debe excluirse la posibilidad de deterioros exteriores o problemas en su capacidad de funcionamiento. 2.Observe el revestimiento exterior y preste atención a deterioros visibles, especialmente en la punta distal. 3.Mire a través del ocular y cerciórese que tiene una imagen clara, la rejilla debe ser claramente reconocible. 4.Si la imagen no fue clara sino turbia, limpie el ocular y el objetivo con un bastoncillo de algodón embebido en alcohol.
	VERIFICACIÓN DE ESTANQUEIDAD. 1.Debe hacerse antes y después de todo procedimiento de limpieza y desinfección. 2.Conecte el Verificador de estanqueidad (12) en el conector de verificación de estanqueidad del fibroscopio (5) 3.Presione la bomba del manómetro e incremente la presión hasta que llegue a la escala de color azul. 4.Observe por aproximadamente 1 minuto la aguja y verifique que no se baje la aguja. Si se baja quiere decir que baja la presión interna y por tanto que el fibroscopio tiene fuga y debe ser enviado al	 INTRODUCIR EL FIBROSCOPIO 1.Introduzca el fibroscopio con la punta distal en posición recta. 2.Cierre el extremo proximal del canal para instrumentos con un tapón si no se va a introducir ningún instrumento. 3.Coloque una válvula de labios desechable para hermetizar el canal si se va a introducir un instrumento. 4.Introduzca instrumentos con mordazas cerradas y ábralas solo cuando la punta distal sobresalga del canal. 5.Tenga en cuenta que la presencia de instrumentos en el canal de trabajo puede limitar la deflexión del fibroscopio.
		

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.